

Diabetes Mellitus

Vamos começar falando sobre um dos temas mais prevalentes em provas de residência médica: o Diabetes Mellitus. Essa é uma doença que você precisa dominar completamente, desde o diagnóstico até as complicações crônicas, porque a banca adora cobrar esse assunto de todas as formas possíveis.

Diagnóstico de Diabetes Mellitus

O diagnóstico do diabetes é fundamentalmente **laboratorial**. Existem três parâmetros principais que você precisa memorizar: **glicemia de jejum maior ou igual a 126 mg/dL**, **hemoglobina glicada maior ou igual a 6,5%** e o **teste oral de tolerância à glicose (TOTG)**. O diagnóstico se confirma com **dois testes positivos**, que podem ser testes diferentes feitos simultaneamente ou o mesmo teste repetido em momentos distintos. Por exemplo, se o paciente apresenta uma glicada de 6,7 hoje e você repete o exame em um mês com resultado de 6,8, o diagnóstico está fechado.

Pegadinha de prova: Quando usar o TOTG? Você vai utilizar esse teste em duas situações principais - quando houver testes discordantes ou naquele paciente pré-diabético que você quer investigar melhor. A Sociedade Brasileira de Diabetes recomenda atualmente o uso do TOTG com medição **1 hora após** o consumo de glicose, porque é mais prático e superior ao teste de 2 horas que era feito antigamente. Decore este valor: **TOTG de 1 hora maior ou igual a 209 mg/dL** fecha critério para diabetes.

Falando em pré-diabetes, os valores que definem essa condição são: **glicemia de jejum entre 100-125 mg/dL**, **glicemia de 1h após TOTG entre 155-209 mg/dL** ou **glicada entre 5,7-6,4%**.

Comentário crítico: Embora o diagnóstico seja tipicamente laboratorial, existe uma exceção importantíssima que a banca adora cobrar. Aquele paciente que chega com

sintomas clássicos de hiperglicemia e uma **glicemia aleatória maior que 200 mg/dL** já tem o diagnóstico fechado. Esse é o caso clássico do diabético tipo 1 que estreia em cetoacidose, chegando ao pronto-socorro já em estado grave.

Os **quatro Ps do diabetes** são fundamentais para você nunca esquecer os sintomas típicos de hiperglicemia: **poliúria, polidipsia, polifagia e perda de peso inexplicada**. Além disso, o paciente apresenta desidratação associada. Existem também sintomas sugestivos, que não fecham o diagnóstico mas fazem você pensar em diabetes: **noctúria** (especialmente em crianças), **visão turva, cansaço, infecções recorrentes** (principalmente candidíase em mulheres devido à glicosúria) e **má cicatrização de feridas**.

Exemplo clínico real: Imagine uma mulher de 47 anos que foi internada há seis semanas por colecistite aguda. Durante a internação, apresentou glicemia aleatória de 203 mg/dL, mas sem sintomas típicos de hiperglicemia. Quatro semanas após a alta, ela traz exames mostrando glicemia de jejum de 133 mg/dL e glicada de 5,4%. Ela tem diabetes? Não! Apesar de ter um exame alterado (glicemia de jejum), você precisa de dois critérios. A glicemia durante a internação não conta porque foi em contexto de estresse metabólico agudo. A glicada está normal. **Pegadinha:** Nessa situação, você deve repetir a glicada ou solicitar um TOTG. Como a paciente recebeu transfusão de hemácias durante a internação, a glicada pode estar falseada, então o melhor é realizar o TOTG.

Rastreio para Diabetes

O rastreio de diabetes tem uma peculiaridade importante: é **universal a partir dos 35 anos**. Todo paciente com 35 anos ou mais deve ser rastreado para diabetes, independentemente de fatores de risco. Poucas doenças têm rastreio universal, então isso já deve acender uma luz vermelha na sua cabeça.

Agora, pacientes com **IMC maior ou igual a 25** e pelo menos um fator de risco adicional devem ser rastreados mesmo antes dos 35 anos. Quais são esses fatores? **História familiar de DM2, doença cardiovascular, hipertensão arterial, HDL abaixo**

de 35 mg/dL, triglicérides acima de 250 mg/dL e três que muita gente esquece mas são cobrados em prova: **síndrome dos ovários policísticos** (independente de obesidade), **acantose nigricans** e **sedentarismo**.

Analogia visual: A acantose nigricans é aquele escurecimento aveludado da pele, geralmente nas dobras (pescoço, axilas, virilhas), que indica resistência insulínica marcante. Se você ver uma imagem dessas em prova pedindo diagnóstico ou conduta, pense imediatamente em rastrear a diabetes.

Tipos de Diabetes

Vamos direto ao que importa para você gabaritar a prova. O **diabetes tipo 1** é aquele paciente que "grita" para você que tem diabetes. Ele chega ruim, muitas vezes já em cetoacidose, precisando de internação em pronto-socorro. É uma doença **autoimune** com produção de autoanticorpos contra células beta pancreáticas (peptídeo C indetectável, anti-GAD positivo).

Já o **diabetes tipo 2** é o oposto. Geralmente é **assintomático** e você só descobre no rastreio. É aquele paciente obeso, por volta dos 40-45 anos, que vai fazer exames de rotina e descobre glicemia alterada. Por isso precisamos rastrear - se dependêssemos só de sintomas, esse paciente só seria diagnosticado quando já tivesse complicações microvasculares estabelecidas.

Mnemônico para LADA e MODY: Use a última letra de cada sigla. **LADA** termina com "A" de **Adulto** - é o diabetes tipo 1 que aparece em adultos, geralmente acima de 30 anos. O paciente começa com sintomas de insulinopenia (perda de peso, desidratação, poliúria) sem ter tido diabetes previamente diagnosticada. **MODY** termina com "Y" de **Young** (jovem) - é o diabetes tipo 2 na criança ou adolescente. É uma doença genética com mutação em gene único relacionado à secreção de insulina, sem autoanticorpos.

Comentário crítico: Uma questão da UNIFESP de 2025 trouxe uma mulher de 17 anos com diabetes monogênico tipo MODY em uso de gliclazida. A pegadinha

estava em saber que no MODY o paciente produz insulina (por isso tem **níveis normais de peptídeo C**), mas essa insulina tem funcionalidade alterada. Como o paciente ainda produz insulina, a glicosúria é positiva. Isso diferencia do DM1, onde o peptídeo C seria indetectável.

Metas Terapêuticas

As metas de hemoglobina glicada são relativamente simples: **a população geral busca HbA1c menor que 7%**. Ponto final. Essa é a meta para a grande maioria dos diabéticos.

Existem duas exceções importantes. Para pacientes com **comorbidades limitantes** (exemplo: cadeirante, paciente com acometimento ortopédico severo), você pode aceitar HbA1c entre 7-7,5%. O risco de hipoglicemia grave não percebida nesses pacientes justifica uma meta um pouco menos rígida.

A segunda exceção, e essa cai muito em prova: **idosos frágeis ou pacientes com alteração cognitiva** têm meta de **HbA1c menor que 8%**. Por quê? O risco desse paciente cair por hipoglicemia e sofrer fratura de fêmur é muito maior do que o risco dele desenvolver complicações microvasculares do diabetes, que levam anos para aparecer e ele não tem sobrevida para isso.

Quanto à **glicosimetria capilar**, para pacientes ambulatoriais use sempre os mesmos valores: **jejum entre 80-130 mg/dL** e **pós-prandial (2 horas após alimentação) entre 140-180 mg/dL**.

Pegadinha: Para **pacientes internados**, os valores mudam. O paciente hospitalizado tem hiperglicemia de estresse em resposta ao processo agudo que motivou a internação (pneumonia, sepse, trauma). Você vai aceitar glicemias um pouco mais altas. Pacientes **não-críticos: 100-140 mg/dL**. Pacientes **críticos: 140-180 mg/dL**. Isso mudou com o estudo Nice Sugar, que mostrou melhor sobrevida com controle mais rigoroso da glicemia em pacientes internados.

Tratamento do Diabetes Tipo 1

O tratamento do DM1 é direto: **insulinoterapia**. Não tem segredo, não tem volta, é insulina. O esquema ideal seria bomba de insulina (mais fisiológico possível), mas como tem pouca disponibilidade no SUS, a gente trabalha com **esquema basal-bolus**.

Você precisa entender os tipos de insulina. A **insulina basal** simula aquela insulina que produzimos continuamente ao longo do dia. No SUS temos principalmente a **NPH** (duração 6-8 horas, precisa de múltiplas aplicações). As outras opções são **detemir** (12 horas), **glargina** (24 horas) e **degludeca** (48 horas, a melhor para manter nível estável).

A **insulina bolus** é aplicada nas refeições. **Mnemônico "LA"**: Lispro e Asparte são as insulinas de ação ultrarrápida. A insulina **regular**, disponível no SUS, não faz pico tão rápido quanto as análogas, então não funciona tão bem como bolus verdadeiro.

A dose inicial típica é **0,5-1 UI/kg/dia** (geralmente começa em 0,8). Dessa dose total, **30-50% será insulina basal** e o restante em bolus. Se usar NPH, faça **2/3 da dose basal pela manhã e 1/3 à tarde**. A insulina regular geralmente é aplicada **três vezes ao dia** nas principais refeições (café, almoço, jantar).

Exemplo prático: Paciente de 40 kg iniciando insulinoterapia. Dose total: 32 UI/dia (0,8 x 40). Basal: aproximadamente 40% = 17 UI (10 UI NPH manhã + 7 UI tarde). Bolus: 18 UI restantes = 6 UI regular em cada refeição.

Hiperglicemia Matinal

Esse é um tópico que aparece com frequência em provas e confunde muita gente. Existem dois fenômenos distintos que causam hiperglicemia ao acordar.

O **fenômeno do alvorecer** é mais simples: ocorre disparada matinal de **hormônios contra-insulínicos** (principalmente cortisol) que eleva a glicemia. O tratamento é aumentar ou atrasar a dose de NPH noturna.

O **efeito Somogyi** é o contrário: o paciente faz **hipoglicemia durante a madrugada**, isso ativa o sistema nervoso simpático e dispara produção de hormônios contrainsulínicos como resposta, resultando em hiperglicemia rebote pela manhã. O tratamento é **lanche noturno** para evitar a hipoglicemia inicial.

Pegadinha de prova: Como diferenciar? Peça para o paciente medir glicemia às 3-4h da madrugada. Se estiver baixa, é Somogyi. Outro sinal: pacientes com Somogyi frequentemente relatam **pesadelos ou sonhos vívidos durante a noite** (sintoma de hipoglicemia).

Tratamento do Diabetes Tipo 2

Aqui o cenário mudou muito nos últimos anos. Até 2-3 anos atrás, metformina era primeira linha para todos. Hoje não é mais assim, embora ela continue sendo muito utilizada. Existem pilares onde atuam os tratamentos: resistência à insulina, aumento de secreção de insulina, aumento da ação da incretina e diminuição da reabsorção tubular de glicose.

A **metformina(Biguanidas)** atua diminuindo a resistência periférica à insulina, especialmente no fígado, reduzindo a neoglicogênese hepática. Efeitos colaterais principais: **desconforto gastrointestinal** (praticamente toda droga antidiabética causa isso), **hipovitaminose B12** e **acidose láctica**. As contraindicações clássicas são **DRC avançada (TFG <30)** e **doença hepática avançada**. Por que não usar em DRC avançada? Risco de acidose láctica, que pode ser fatal.

Rosiglitazona ou pioglitazona(Glitazonas) é menos utilizada, também atua diminuindo a resistência periférica à insulina, especialmente a nível muscular. Efeitos colaterais principais: **Ganho de peso**, congestão sistêmica, **piora da IC**, aumenta o risco de fraturas. Contraindicações: **IC NYHA III ou IV**.

As **sulfonilureias** (glibenclamida, gliclazida) aumentam a secreção de insulina. São secretagogos potentes. O grande problema é a **hipoglicemia** e o **ganho de peso**.

Disponível no SUS, é muito utilizada, mas você precisa ficar atento ao risco de hipoglicemia grave.

Comentário crítico: Uma questão da USP Ribeirão 2025 trouxe exatamente esse cenário - homem de 70 anos usando glibenclamida apresentou coma hipoglicêmico (glicemia 33 mg/dL). Após correção com glicose EV, recuperou completamente. A conduta? Internar por 24-48h e trocar glibenclamida por linagliptina (inibidor DPP4 com pouquíssimos efeitos colaterais). Nunca trocar um secretagogo por outro secretagogo!

Os **inibidores da DPP4** (sitagliptina, vildagliptina) aumentam a ação incretínica ao inibir a degradação do GLP-1. O mais importante sobre essas drogas é que têm **pouquíssimos efeitos colaterais** e são muito bem toleradas. Raramente usadas em monoterapia.

Os **análogos do GLP-1** (liraglutida, semaglutida, dulaglutida) são a grande revolução recente. São a **primeira opção em pacientes obesos**, em monoterapia ou associados quando HbA1c >7,5%. Têm efeito importante na **perda de peso** (podem ser usados até em não-diabéticos para obesidade), **benefício cardiovascular** (especialmente em pacientes com DAC prévia) e **benefício nefroprotetor**. O efeito colateral principal continua sendo **gastrointestinal** (náuseas, vômitos), que às vezes limita o uso.

Análogo clínico: Pense no análogo de GLP-1 como uma droga que "engana" o corpo fazendo ele pensar que acabou de comer, mesmo em jejum. Isso aumenta a produção de insulina de forma glicose-dependente (não causa hipoglicemia isoladamente), reduz o esvaziamento gástrico e aumenta a saciedade. Por isso o efeito potente na perda de peso.

Os **inibidores de SGLT2** (empagliflozina, dapagliflozina) bloqueiam a reabsorção tubular de glicose, fazendo o paciente eliminar mais glicose na urina. São **extremamente cardioprotetores e nefroprotetores**. Primeira linha em pacientes com **alto risco cardiovascular** ou **DRC** (se clearance entre 20-60). Fazem parte da terapia quádrupla da insuficiência cardíaca mesmo em não-diabéticos.

Efeitos colaterais: **infecção urinária de repetição** (óbvio, tem glicose na urina o tempo todo) e **cetoacidose euglicêmica** (cetoacidose com glicemia <200 mg/dL, muito importante!).

Algoritmo de Tratamento do DM2

Primeira pergunta: **o paciente tem obesidade ou sobrepeso?** Se sim, **inicie análogo de GLP-1**. Se a HbA1c for $<7,5\%$, monoterapia. Se HbA1c $\geq 7,5\%$, dupla terapia (a segunda droga depende do risco CV). Se HbA1c $>9\%$, considere terapia tripla ou insulinoterapia.

Se o paciente **não for obeso**, avalie o **risco cardiovascular**. Se for alto/muito alto, inicie **iSGLT2**. Se for moderado/baixo, pode iniciar **metformina**.

Pegadinha: Se não houver resposta, vá escalando: monoterapia → dupla → tripla → quádrupla ou insulina. A sociedade brasileira agora permite até quatro drogas orais antes de partir para a insulina.

Insulinoterapia no DM2

Três situações indicam insulina no DM2: **(1) refratariedade terapêutica** (já está em terapia quádrupla e não responde), **(2) sintomas de insulinopenia** (perda de peso, poliúria, polidipsia - o paciente está "gritando" que precisa de insulina), **(3) HbA1c $\geq 9\%$ ao diagnóstico**.

Comentário crítico: Antigamente, qualquer HbA1c ≥ 9 era indicação absoluta de insulina. Hoje, se for paciente obeso sem sintomas de insulinopenia, você pode tentar terapia tripla/quádrupla agressiva antes. Mas se houver perda de peso ou sintomas claros, não perca tempo - esse paciente está insulinopênico e precisa de insulina.

Comece sempre com **insulina bedtime** (NPH noturna) em dose baixa (0,5 UI/kg). Em pacientes obesos, considere associar análogo de GLP-1 para balancear o ganho de peso que a insulina causa.

Complicações Agudas: Cetoacidose Diabética

A fisiopatologia da CAD é linda e você precisa entender para nunca mais esquecer. O paciente diabético tipo 1 tem **hipoinsulinismo absoluto** com **catabolismo exacerbado**. Sem insulina (hormônio anabólico), o corpo entra em modo de destruição.

Duas coisas acontecem simultaneamente: **(1)** Como não tem energia (glicose não entra nas células), começa **neoglicogênese e glicogenólise** desesperadas, piorando ainda mais a hiperglicemia. **(2)** Como precisa de energia alternativa, começa **lipólise e proteólise** massivas. A quebra de lipídios gera **cetoácidos** (ácido beta-hidroxibutírico, acetoacético e acetona), causando **acidose metabólica**.

Critérios diagnósticos da CAD: Pegue o nome da doença - **cetoacidose diabética**.

- **Ceto:** corpos cetônicos na urina (3+/4+)
- **Acidose:** pH <7,35 ou bicarbonato <15
- **Diabética:** glicemia >250

Clínica da CAD: O paciente hiperglicêmico desenvolve **glicosúria** → **poliúria** → **desidratação** → **dor abdominal** (pegadinha: CAD é causa de abdome agudo não-cirúrgico!). A desidratação grave leva a **confusão mental e coma**.

A cetogênese produz **cetona** (hálito cetônico, aquele cheiro de maçã podre) e **ácidos** (ác. betahidroxibutírico e ác. acetoacético)(acidose metabólica → **respiração de Kussmaul**, tentando "lavar" o excesso de ácidos eliminando CO₂).

O déficit energético causa **fome e polifagia**. Juntando tudo: paciente com fome, fazendo muito xixi, desidratado, com dor abdominal, hálito cetônico, respiração rápida e profunda, evoluindo para coma.

Tratamento da CAD: VIP

- Volume (primeira medida, antes de tudo!)
- Insulina
- Potássio

Volume: 15-20 mL/kg na **primeira hora** com NaCl 0,9%. Isso é muito volume, mas o paciente está extremamente desidratado.

Potássio: Antes de iniciar insulina, avalie o potássio!

- K <3,3: repor potássio, NÃO iniciar insulina ainda (risco de hipocalemia grave)
- K 3,3-5,2: iniciar reposição de potássio E insulina simultaneamente
- K >5,2: pode iniciar insulina sem repor potássio

Insulina: Se K permitir, iniciar **0,1 UI/kg/h EV**, buscando queda de **50-70 mg/dL por hora**. Não mais rápido que isso (risco de edema cerebral).

Pegadinhas do tratamento:

Sódio: Sempre avaliar o **sódio corrigido** (sódio cai 1,6 mEq para cada 100 mg/dL de aumento na glicemia). Após 1h de volume, se Na ≥ 135 , troque para NaCl 0,45%. Se Na <135, continue NaCl 0,9%.

Glicose: Quando a glicemia cair para <250, **adicione SG 5%** à infusão. Você vai continuar a insulina (para corrigir a acidose, não a glicemia), então precisa dar glicose para evitar hipoglicemia.

Bicarbonato: Só indicado se pH <6,9. Acima disso, não muda mortalidade.

Crítérios de resolução da CAD: Esqueça a glicemia, o que importa é resolver a acidose!

- pH >7,3
- Bicarbonato >15
- Anion gap <12

Antes de desligar a insulina EV, inicie insulina SC e espere 1-2 horas para descontinuar a bomba (senão o paciente volta para CAD).

Cetoacidose Euglicêmica

Essa é minha aposta para a prova difícil. É uma CAD com **glicemia <200 mg/dL**. O paciente tem todos os critérios de CAD, mas a glicemia é "normal" ou pouco elevada. A gente raramente pensa em CAD quando vê glicemia normal, mas se o paciente tem cetose + acidose, é CAD.

Gatilho de prova: Paciente usando **iSGLT2** (dapa ou empagliflozina) com clínica de CAD mas glicemia baixa = cetoacidose euglicêmica. Outras situações: gestação, doença hepática, alcoolismo, pancreatite.

Exemplo de caso: Paciente diabética tipo 2 de 85 anos usando metformina, gliclazida e **dapagliflozina**, internada por pneumonia, em jejum para exame. Enfermagem relata cheiro de acetona no quarto, paciente desidratada, glicemia 190. Esse é o cenário clássico de cetoacidose euglicêmica que pode cair em prova.

Estado Hiperglicêmico Hiperosmolar

Menos comum em prova, mas importante conhecer. É o paciente com **glicemia bizarramente alta** (600-700 mg/dL, aquele "HI" no glicosímetro), pH >7,3, bicarbonato >18, mas **osmolaridade muito alta** (>320 mOsm/L).

Acontece classicamente em idoso acamado, DM2, que não está sendo bem cuidado. A clínica é **coma** por hiperosmolaridade.

Tratamento igual CAD, mas troque logo para **NaCl 0,45%** (não quer dar mais osmolaridade). Critério de resolução: **osmolaridade <310**.

Complicações Crônicas: Microangiopatia

Todas as complicações microvasculares têm a mesma base fisiopatológica: **microangiopatia diabética**. A hiperglicemia crônica causa inflamação vascular, espessamento da parede dos pequenos vasos (arteriosclerose) e lesão dos vasa vasorum (vasos dos nervos), vasa nervorum e capilares glomerulares.

Rastreio: DM1 → iniciar **5 anos após diagnóstico** (não dá tempo de ter complicação antes). DM2 → iniciar **logo ao diagnóstico** (pode ter anos de doença não diagnosticada).

Nefropatia Diabética

É a **principal causa de DRC no Brasil** e é a **principal causa de transplante renal**. A lesão glomerular direta + ativação do SRAA causam **proteinúria** como primeira manifestação.

Rastreio: Relação albumina/creatinina urinária (muito mais prático que urina 24h).

- **A1:** <30 mg/g (normal)
- **A2:** 30-300 mg/g (microalbuminúria)
- **A3:** ≥300 mg/g (albuminúria franca)

Retinopatia Diabética

É a **principal causa de cegueira adquirida no Brasil**. Rastreio com **fundo de olho** anualmente.

Fase precoce: Assintomática, achados mínimos. **Microaneurismas** e **exsudatos duros**. Só diagnostica no rastreio. Tratamento: controle glicêmico.

Fase avançada: **Hemorragias em chama de vela**, **manchas algodinosas** (exsudatos coalescentes), **veias em conta de rosário**. Tratamento: controle glicêmico rigoroso.

Fase proliferativa: **Neoangiogênese** (produção de novos vasos anômalos). O paciente evolui com perda visual. Tratamento: fotocoagulação a laser (resposta

limitada). Esse é o ponto que você quer evitar que o paciente chegue, porque é irreversível.

RESUMO DOS GATILHO

Diagnóstico de DM:

1: Dois dos seguintes:

Glicemia de jejum ≥ 126
Hemoglobina glicada $\geq 6,5\%$
Teste oral de tolerância à glicose alterado

2- Sintomas de hiperglicemia + Glicemia aleatória > 200

Metas Terapêuticas:

HbA1c: população geral $< 7\%$ | idosos frágeis $< 8\%$

Glicosimetria capilar:

jejum: 80–130 | pós-prandial 140–180

Pacientes internados: 140–180

Tipos de DM:

DM1: diabetes com clínica florida, sem dúvidas no diagnóstico

DM2: geralmente assintomática, isso explica a necessidade do rastreio

LADA: DM1 DO ADULTO

MODY: DM2 NO JOVEM

Tratamento DM1:

Insulinoterapia Plena com Basal Bolus → 0,5–1UI/kg/dia

BASAL: NPH, Detemir, Glargina, Degludeca

BOLUS: Regular, Lispro, Asparte

Tratamento DM2:

Metformina: efeitos colaterais principais: Hipovitaminose B12 | Acidose Lática, contraindicação principal: DRC (TFG < 30)

Sulfonilureias: aumenta a produção de insulina, Glibenclamida | Glicazida, hipoglicemia

Inibidor da DPP IV: Sitagliptina | Vildagliptina, pouco efeito colateral

Análogos do GLP-1: Liraglutida | Semaglutida | Dulaglutida, primeira opção em pacientes obesos, muito importante na perda de peso

iSGLT-2: Empagliflozina e Dapagliflozina, cardioprotetor e nefroprotetor, colaterais: ITU de repetição, Cetoacidose Euglicêmica

Efeito Somogyi:

hipoglicemia na madrugada – efeito rebote de hiperglicemia na manhã – tratamento com lanche noturno

Fenômeno do Alvorecer:

hiperglicemia matinal por disparada matinal de hormônios contrainsulínicos

CAD:

Critérios Diagnósticos: Corpos Cetônicos na Urina (3+/4+) | pH < 7,35 ou Bic < 15 | Glicemia > 250

Clínica da CAD: Fome/polifagia | Poliúria | Dor Abdominal | Hálito Cetônico | Respiração de Kussmaul

Critérios de Resolução da CAD: pH > 7,3 | Bic > 15 | AG < 12

CAD euglicêmica: Clínica de CAD, sem hiperglicemia, em paciente usuário de iSGLT-2

Complicações Microvasculares:

Rastreio: DM1 – 5 anos após o diagnóstico | DM2 – logo ao diagnóstico

Nefropatia: Rastreio com avaliação de relação A/C | A1: < 30 mg/g | A2: entre 30–300 mg/g | A3: ≥ 300 mg/g

Retinopatia:

Precoce: microaneurismas e exsudatos duros

Avançada: Manchas Algodonosas, Hemorragia em Chama de Vela e Veias em Conto de Rosário

Proliferativa: neoangiogênese